Fiche projet — Suivi des mesures d'isolement et de contention

Suivi-mesures-isocont, version 1.0 — logiciel libre (licence EUPL-1.2), gratuit, déployable dans tout établissement autorisé en psychiatrie.

En bref	
Objet	Suivre les durées des mesures d'isolement et de contention, anticiper l'information et la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD), produire le registre anonymisé et le rapport annuel.
Pour qui	Infirmiers, aides-soignants, secrétariat médical, cadres de santé des unités de psychiatrie ; direction des soins pour le rapport annuel.
Coût	Aucun coût de licence. Mise en place : quelques heures du service informatique (DSI ou direction du numérique, selon l'établissement), une formation courte des équipes.
Où sont les données	Dans un dossier du réseau de l'établissement, chiffrées. Rien n'est envoyé à l'extérieur.
Ce que l'outil ne fait pas	Il ne remplace ni le dossier patient informatisé (DPI), ni la prescription médicale, ni la surveillance clinique.

1. Contexte

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement le recours à l'isolement et à la contention en psychiatrie : décisions médicales motivées pour des durées limitées, renouvellements, information du juge des libertés et de la détention puis saisine au-delà de seuils de durée cumulée, information d'un tiers, et tenue d'un **registre** dans chaque établissement. Ce registre, sans données nominatives, est consultable par la commission départementale des soins psychiatriques, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les parlementaires ; il alimente un **rapport annuel** sur ces pratiques.

Le respect de ces délais repose sur des calculs délicats : cumul des durées sur quinze jours glissants, mesures qui se succèdent ou se chevauchent, cycles de renouvellement, rythme particulier des mesures longues, remise à zéro après une mainlevée du juge. Une erreur ou un retard peut conduire le juge à ordonner la mainlevée de la mesure.

2. Le besoin

Les DPI couvrent de plus en plus la prescription et la surveillance infirmière des mesures. En revanche, **le suivi des durées cumulées, le calendrier des communications au JLD et le registre anonymisé** y sont souvent absents ou insuffisants. Les équipes compensent avec des tableaux et des classeurs bureautiques, fragiles (fichiers verrouillés en saisie simultanée, corruption, macros bloquées) et peu protégés.

Suivi-mesures-isocont est né dans une unité d'hospitalisation psychiatrique, d'un classeur Excel utilisé en conditions réelles (versions 1.0 à 1.3), puis réécrit en application web pour lever ces limites.

3. Ce que fait l'outil

Fonction	Détail
Report des décisions médicales	L'IDE reporte le début et la fin de chaque mesure : psychiatre décisionnaire, date, heure, lieu (chambre de soins intensifs ou non). Il reporte aussi les levées temporaires (pause avec durée ou heure de reprise prévue) et leur reprise.
Échéances JLD	Calcul automatique des dates limites d'information, de saisine et de décision, cycle par cycle, avec alertes visuelles. Calculs vérifiés par des tests automatiques.
Envois JLD	Secrétariat (et IDE le week-end) : enregistrement des informations, saisines et décisions reçues ; repérage des envois hors délai.
Décompte JLD	Document imprimable, PDF ou CSV détaillant la durée cumulée, à joindre à la saisine. Présentation et données exportées réglées par un masque d'établissement ou propre à chaque service.
Information des tiers	Traçabilité par cycle : qui a informé (psychiatre ou autre fonction prévue par l'établissement, liste paramétrable), quel tiers, ou pourquoi aucun tiers n'a pu l'être.
Surveillance en chambre de soins intensifs (CSI)	Professionnels présents par poste, nécessaires au registre.
Reprise de l'historique	À partir du registre du service, quel que soit l'outil utilisé jusque-là (export CSV ou Excel, colonnes à faire correspondre). Mesures reconstituées, numérotation conservée ou recalculée, contrôle et aperçu de l'impact avant import.
Registre	Conforme à l'article L. 3222-5-1 (identifiant permanent du patient ou IPP, âge, mode d'hospitalisation, début, durée, psychiatre, soignants), catégories A à E, numérotation annuelle, impression et export. Version occultée pour les demandes de communication d'un tiers (droit d'accès aux documents administratifs, CADA).
Rapport annuel	Indicateurs « L'isolement et la contention en chiffres » (année N et N-1), suivi réglementaire, répartition mensuelle, export pseudonymisé.
Vigilance	Tableau de bord : échéances proches ou dépassées, tiers à renseigner, patients en soins libres, mineurs, cumuls élevés.
Saisie à plusieurs	Plusieurs postes peuvent saisir en même temps sans perte d'information ; les saisies contradictoires sont signalées pour arbitrage.
Traçabilité	Chaque saisie est nominative, horodatée, jamais effacée ; les corrections sont elles-mêmes tracées.
Formation	À la connexion, chaque agent choisit entre les données réelles et le **mode formation** : un jeu de données fictives chiffré à part, avec son vrai compte, ses rôles et ses services ; bandeau violet sur tous les écrans. L'administrateur peut retirer l'accès compte par compte et régénérer le jeu.

4. Organisation et rôles

Rôle	Responsabilités dans l'outil
IDE et aide-soignant(e) (AS)	Mêmes droits : report des décisions de début, de fin et de pause, information des tiers, professionnels en CSI, envois JLD le week-end ou en l'absence du secrétariat.
Secrétaire	Envois et suivi JLD, décomptes.
Cadre de santé	Pilotage, corrections tracées, registre, statistiques.
Administrateur	Comptes (un par un ou en lot à partir d'une liste d'agents), services affectés à chaque compte, accès au mode formation, réinitialisation des mots de passe perdus, clés de secours, paramétrage, import. Rôle cumulable avec celui de cadre.
Psychiatres	Non utilisateurs à ce stade : la décision et la prescription restent dans le DPI.
Service informatique	Mise à disposition du dossier réseau et de l'application, sauvegardes, postes.
Délégué à la protection des données (DPO, référent RGPD)	Inscription au registre des traitements, analyse d'impact.

Chaque agent ne voit que les services qui lui sont affectés. Les comptes sont créés avec un mot de passe provisoire, que l'agent doit obligatoirement remplacer à sa première connexion.

5. Sécurité et conformité, en résumé

- **Les données restent dans l'établissement**, sur un dossier du réseau, chiffrées (AES-256) sur le poste avant d'y être écrites.
- **Aucun serveur à installer, aucune connexion sortante** : l'application est un ensemble de fichiers statiques qui ne peuvent rien envoyer sur Internet.
- **Accès nominatifs**, mot de passe personnel imposé à la première connexion, rôles, verrouillage automatique, clés matérielles (YubiKey) et code de secours papier.
- **Hébergement de données de santé** : les données n'étant confiées à aucun prestataire, la certification d'hébergeur de données de santé (HDS) ne devrait pas s'appliquer ; la qualification revient au délégué à la protection des données et au service informatique (voir la fiche technique).
- **RGPD** : traitement à inscrire au registre ; une analyse d'impact est probablement requise (données de santé de personnes vulnérables). Les éléments utiles sont fournis dans le kit.

6. Bénéfices attendus et indicateurs de suivi

Bénéfice	Indicateur proposé
Moins de communications au JLD hors délai	Nombre de cycles avec au moins une communication hors délai (calculé par l'outil)
Registre complet et conforme	Part des entrées A et C avec professionnels renseignés ; délai de production du registre
Rapport annuel produit sans ressaisie	Temps consacré à la préparation du rapport

Bénéfice	Indicateur proposé
Meilleure information des tiers	Part des mesures avec information du tiers renseignée
Fiabilité	Nombre d'incidents (perte de saisie, fichier inaccessible)

7. Déploiement type

Étape	Contenu	Durée indicative
1. Cadrage	Présentation de cette fiche à la direction, au service informatique et au délégué à la protection des données ; choix du mode d'hébergement.	2 à 4 semaines
2. Validation	Fiche technique revue par le service informatique et le responsable de la sécurité informatique (RSSI) ; registre des traitements et analyse d'impact par le délégué à la protection des données.	selon l'établissement
3. Installation	Dossier réseau, publication de l'application, test sur un poste type.	1 demi-journée du service informatique
4. Paramétrage	Services, CSI, postes de surveillance, comptes, clés de secours ; import éventuel de l'existant.	1 demi-journée
5. Pilote	Une unité, en parallèle de l'outil actuel, avec comparaison des échéances.	1 à 2 mois
6. Généralisation	Autres unités, abandon de l'outil antérieur.	progressive

Formation : 20 à 30 minutes par agent, à partir du guide utilisateur du kit, en se connectant en mode formation.

8. Risques et parades

Risque	Parade
Perte de tous les moyens de déverrouillage	Deux clés matérielles d'administration dont une au coffre, code de secours papier scellé, procédure testée chaque année.
Indisponibilité du réseau	Procédure dégradée papier (modèle fourni), ressaisie avec les heures réelles.
Maintenance dépendante d'une seule personne	Logiciel libre documenté et testé, repris par toute équipe ou tout autre établissement.
Outil non reconnu comme support du registre	Décision institutionnelle avant la mise en production.
Navigateur non compatible	Edge ou Chrome à jour sur les postes concernés.

9. Logiciel libre et gouvernance

Le code est publié sous **licence publique de l'Union européenne (EUPL-1.2)** : chaque établissement peut l'utiliser, l'étudier, l'adapter et le redistribuer ; les versions modifiées et redistribuées restent libres. Il est fourni sans garantie et sans support commercial. Les évolutions sont proposées et suivies sur le dépôt public du projet ; un établissement peut aussi déployer une version qu'il a lui-même vérifiée et figée.

Le logiciel n'est pas un dispositif médical : il n'émet aucune recommandation clinique et n'intervient pas dans la décision.

10. Décisions attendues

- ☐ Accord de la direction et de la direction des soins pour un pilote.
- ☐ Mode d'hébergement retenu par le service informatique (intranet recommandé).
- ☐ Inscription au registre des traitements et analyse d'impact par le délégué à la protection des données.
- ☐ Reconnaissance de l'outil comme support du registre prévu à l'article L. 3222-5-1, ou articulation avec le registre existant.
- ☐ Désignation de l'administrateur fonctionnel et des détenteurs des clés de secours.

Référent du projet dans l'établissement : ___ — Date : _ / _ / __

Sources : article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; Agence du numérique en santé (ANS), champ d'application de l'hébergement de données de santé ; CNIL, liste des traitements pour lesquels une analyse d'impact est requise. Ce document ne constitue pas un avis juridique.